

Cannabiskonsum macht nicht aggressiv.

✂ Eher falsch

Einordnung

Aggressionen bezeichnen im Allgemeinen Verhaltensweisen oder Tendenzen mit dem Ziel, eigene Positionen machtvoll zu vertreten und durchzusetzen. Sie können gegenüber anderen mit verbalen, physischen und psychischen Attacken verbunden sein und auch Schaden zufügen. Die Entstehung von Aggressionen ist ein komplexer Prozess, der durch ein Zusammenspiel aus biologischen, psychologischen und sozialen Einflüssen bestimmt wird. Dabei spielen emotionale Zustände, soziale und Umweltfaktoren, kulturelle und situative Bedingungen sowie Persönlichkeitsmerkmale und individuelle Faktoren wie Impulsivität und Impulskontrolle eine Rolle.

Synthese

Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und externalisierendem Verhalten, wie Aggressionen. Insbesondere chronischer Cannabiskonsum wird als potenzieller Risikofaktor für gesteigerte Aggressivität beschrieben, auch bei jungen Menschen.

Zentrale Erkenntnisse

- Studien beschreiben einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und externalisierendem Verhalten, wie Aggression und Impulsivität^[11, 12] sowie gewalttätigem Verhalten,^[13-16] insbesondere bei Jugendlichen^[13] oder Menschen mit schweren psychischen Störungen.^[17]
- Häufiger und langfristiger Cannabiskonsum wird als potenzieller Risikofaktor für Reizbarkeit, Aggression und Gewalt identifiziert.^[13, 15]
- Bei Menschen mit einer Cannabisabhängigkeit können Entzugssymptome mit einer erhöhten Reizbarkeit und Aggressivität einhergehen.^[18, 19]

Daten nach Zielgruppen

Zielgruppe	👁 Kenntnis %	🚩 Bedeutung Punkte	🎯 Richtigkeit Punkte	🛡 Prävention Punkte	🌐 Bev. Relevanz Punkte
👤 Volljährige (18-70)	24	62	58	38	10
👤 Minderjährige (16-17)	25	62	62	36	10
👤 Konsument*innen	58	72	46	49	k. A.
👤 Junge Erwachsene	36	63	55	40	k. A.
👤 Eltern	30	63	55	40	k. A.

👁 **Kenntnis** — Anteil der Befragten, die den Mythos kennen (0–100 %). Höher = bekannter.

🚩 **Bedeutung** — Subjektive Wichtigkeit des Mythos für den eigenen Umgang mit Cannabis (0–100 Punkte). Nur bei Personen erhoben, die den Mythos kennen.

🎯 **Richtigkeit** — Übereinstimmung der Einschätzung mit der wissenschaftlichen Klassifikation (0–100 Punkte). Höher = treffender.

🛡 **Prävention** — Kombination aus Bedeutung und Fehleinschätzung (0–100 Punkte). Höher = größerer Präventionsbedarf.

🌐 **Bevölkerungsrelevanz** — Bevölkerungsbezogene Risikobedeutung (0–100 Punkte) — kombiniert die individuelle Präventionsbedeutung mit dem Verbreitungsgrad des Mythos. Nur für Volljährige (18–70) und Minderjährige (16–17) erhoben.

Referenzen

1. Carnide, N., et al. Cannabis use motives and associations with personal and work characteristics among Canadian workers: a cross-sectional study. *J Occup Med Toxicol*. 2024. 19. (1): p. 25. 10.1186/s12995-024-00424-7.
2. Balneaves, L.G., et al. Youth and Young Adults' Knowledge and Perceptions of Risks and Benefits Regarding Cannabis Products: A Cross-Sectional Analysis of Over 1,700 Individuals. *J Psychoactive Drugs*. 2024. p. 1-10. 10.1080/02791072.2024.2371028.
3. Ghelani, A. Motives for Recreational Cannabis Use among Mental Health Professionals. *Journal of Substance Use*. 2021. 26. (3): p. 256-260. 10.1080/14659891.2020.1812124.
4. Nabata, K.J., et al. The Therapeutic Potential and Usage Patterns of Cannabinoids in People with Spinal Cord Injuries: A Systematic Review. *Curr Neuropharmacol*. 2021. 19. (3): p. 402-432. 10.2174/1570159X18666200420085712.
5. Skobic, I., et al. Marijuana versus evidence-based treatments for sleep and relaxation: A cross-sectional study of use and dose modification following involuntary job loss. *Sleep Health*. 2021. 7. (1): p. 113-117. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2020.06.008>.
6. Kinnunen, K., et al. A preliminary study evaluating self-reported effects of cannabis and cannabinoids on neuropathic pain and pain medication use in people with spinal cord injury. *Front Pain Res (Lausanne)*. 2023. 4. p. 1297223. 10.3389/fpain.2023.1297223.
7. Stith, S.S., et al. Understanding feeling "high" and its role in medical cannabis patient outcomes. *Front Pharmacol*. 2023. 14. p. 1135453. 10.3389/fphar.2023.1135453.
8. Lavie-Ajayi, M. and P. Shvartzman. Restored Self: A Phenomenological Study of Pain Relief by Cannabis. *Pain Med*. 2019. 20. (11): p. 2086-2093. 10.1093/pm/pny176.
9. Cuttler, C., A. Spradlin, and R.J. McLaughlin. A naturalistic examination of the perceived effects of cannabis on negative affect. *J Affect Disord*. 2018. 235. p. 198-205. 10.1016/j.jad.2018.04.054.
10. De Sousa Fernandes Perna, E.B., et al. Subjective aggression during alcohol and cannabis intoxication before and after aggression exposure. *Psychopharmacology (Berl)*. 2016. 233. (18): p. 3331-40. 10.1007/s00213-016-4371-1.
11. Sorkhou, M., R.H. Bedder, and T.P. George. The Behavioral Sequelae of Cannabis Use in Healthy People: A Systematic Review. *Front Psychiatry*. 2021. 12. p. 630247. 10.3389/fpsy.2021.630247.
12. Girgis, J., et al. Cannabis Use and Internalizing/Externalizing Symptoms in Youth: A Canadian Population-Based Study. *J Adolesc Health*. 2020. 67. (1): p. 26-32. 10.1016/j.jadohealth.2020.01.015.
13. Dellazizzo, L., et al. Violence and Cannabis Use: A Focused Review of a Forgotten Aspect in the Era of Liberalizing Cannabis. *Front Psychiatry*. 2020. 11. p. 567887. 10.3389/fpsy.2020.567887.
14. Rafiei, D. and N.J. Kolla. Fact or Faction Regarding the Relationship between Cannabis Use and Violent Behavior. *J Am Acad Psychiatry Law*. 2022. 50. (1): p. 44-55. 10.29158/JAAPL.210034-21.
15. Schoeler, T., et al. Continuity of cannabis use and violent offending over the life course. *Psychol Med*. 2016. 46. (8): p. 1663-77. 10.1017/S0033291715003001.
16. Campeny, E., et al. The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2020. 33. p. 1-35. 10.1016/j.euroneuro.2020.02.003.
17. Sorkhou, M., et al. Does cannabis use predict aggressive or violent behavior in psychiatric populations? A systematic review. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 2022. 48. (6): p. 631-643. 10.1080/00952990.2022.2118060.
18. Connor, J.P., et al. Clinical management of cannabis withdrawal. *Addiction*. 2022. 117. (7): p. 2075-2095. 10.1111/add.15743.
19. Schlienz, N.J., et al. Cannabis Withdrawal: A Review of Neurobiological Mechanisms and Sex Differences. *Curr Addict Rep*. 2017. 4. (2): p. 75-81. 10.1007/s40429-017-0143-1.